

1

बाल्यावस्था को समझना



टिप्पणियाँ

- 1.1 भूमिका
- 1.2 सीखने के प्रतिफल
- 1.3 बाल्यावस्था की अवधारणा का निर्माण
- 1.4 समकालीन समय में बाल्यावस्थाएँ
- 1.5 बहुविध बाल्यावस्थाएँ
- 1.6 बाल्यावस्था और जेन्डर परिप्रेक्ष्य
- 1.7 बाल्यावस्था और डिजिटल संसार
- 1.8 सारांश
- 1.9 पाठांत प्रश्न
- 1.10 संदर्भ ग्रंथ

1.1 भूमिका

बाल्यावस्था की यह धारणा प्रायः स्वाभाविक और सार्वभौमिक मानी जाती है, मानो यह जीवन का एक प्राकृतिक चरण हो। परंतु वास्तव में बाल्यावस्था की अवधारणा समाज और इतिहास द्वारा निर्मित होती है तथा यह विभिन्न संस्कृतियों, समय और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अतीत में, विशेषकर कृषि-प्रधान समाजों में, बच्चों को सामान्यतः छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता था और उनसे घर के कामों तथा पारिवारिक दायित्वों में सहायता की अपेक्षा की जाती थी।

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

समय के साथ औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था के विकास, कानूनी परिवर्तनों तथा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों से जुड़े विमर्शों ने बाल्यावस्था को सीखने, खेलने और विकास के लिए एक स्वतंत्र एवं संरक्षित चरण के रूप में देखने की समझ को मजबूत किया है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन आधुनिक भारत में बाल्यावस्थाओं को समझने का आधार प्रदान करता है।

आज के विश्व में बाल्यावस्था सभी के लिए समान नहीं है। आधुनिक भारत में किसी बच्चे का पालन-पोषण परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जेंडर, संस्कृति, निवास स्थान तथा प्रौद्योगिकी तक पहुँच जैसे अनेक कारकों के जटिल संयोजन से प्रभावित होता है। जहाँ कुछ बच्चों को अच्छे विद्यालय, सुरक्षित आवास और उचित स्वास्थ्य-सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, वहीं अनेक बच्चे गरीबी, श्रम और सामाजिक बहिष्करण जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। यह विविधता इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि बाल्यावस्था कोई एकरूप अनुभव नहीं है, बल्कि अनेक बाल्यावस्थाएँ हैं, जिनकी परिस्थितियाँ और समस्याएँ अलग-अलग होती हैं।

विविध बाल्यावस्थाओं की अवधारणा इस विविधता को स्वीकार करती है। भारत में जन्म के पश्चात बच्चों का जीवन मुख्यतः उनके परिवार और परिवेश से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, भिन्न-भिन्न आर्थिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की बाल्यावस्थाएँ भी भिन्न होती हैं। उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे प्रायः अपेक्षाकृत सुविधाजनक वातावरण में बड़े होते हैं, जहाँ उन्हें निजी विद्यालयों, डिजिटल संसाधनों तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों तक बेहतर पहुँच प्राप्त होती है।

मध्यम आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को इन सुविधाओं तक सीमित पहुँच मिलती है, साथ ही वे विद्यालयी अध्ययन, सामाजिक उन्नति की अपेक्षाओं तथा अभिभावकों की आकांक्षाओं से उत्पन्न दबाव का भी अनुभव करते हैं। वहीं, निम्न आय वर्ग के परिवारों में पलने वाले अनेक बच्चों को विद्यालय तक नियमित पहुँच प्राप्त नहीं हो पाती और वे कम आयु में ही श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ उनकी बाल्यावस्था को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं और कई बार उसे समय से पहले समाप्त कर देती हैं।

बाल्यावस्था के निर्माण में जेंडर की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ कई बार बालकों और बालिकाओं के लिए भिन्न अपेक्षाएँ और सीमाएँ निर्धारित कर देती हैं। कुछ बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने या स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अवसर सीमित रूप में मिलते हैं, जबकि कई बार बालकों पर अत्यधिक दायित्व उठाने या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने का दबाव डाला जाता है। बालकों और बालिकाओं के ये भिन्न अनुभव उनके विकास की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देते हैं।

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

समकालीन समय में डिजिटल संसार का विस्तार भी बाल्यावस्था को गहराई से प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों या अपेक्षाकृत समृद्ध परिवेश में रहने वाले अनेक बच्चे अध्ययन, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं। किंतु इसके साथ ही स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता, साइबर उत्पीड़न तथा डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच जैसी चिंताएँ भी सामने आती हैं, विशेषकर वंचित एवं कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बच्चों के लिए। डिजिटल विभाजन मौजूदा असमानताओं को और गहरा करता है तथा तीव्र परिवर्तनशील समाज में बाल्यावस्था को समझने की प्रक्रिया को जटिल बनाता है।

यह अध्याय उपर्युक्त सभी पक्षों का विस्तार से विवेचन करेगा, जिससे बाल्यावस्था को उसके विविध अनुभवों, चुनौतियों तथा संभावनाओं के समग्र परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके।



सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी :

- बाल्यावस्था की अवधारणा का बोध विकसित करते हैं;
- समकालीन समय में बाल्यावस्था के घटकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हैं;
- यह समझते हैं कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय संदर्भों के अनुसार बाल्यावस्था के अनुभव भिन्न-भिन्न होते हैं;
- बाल्यावस्था के निर्माण में जेंडर को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचानते हैं;
- बाल्यावस्था के अनुभवों को आकार देने में डिजिटलीकरण की भूमिका पर चिंतन करते हैं।

1.3 बाल्यावस्था की अवधारणा का निर्माण

बाल्यावस्था की अवधारणा न तो स्थिर है और न ही सार्वभौमिक; बल्कि यह एक सामाजिक एवं ऐतिहासिक रूप से निर्मित संकल्पना है, जो समय के साथ विकसित होती रही है। बाल्यावस्था की यह संकल्पना व्यापक सामाजिक मूल्यों, आर्थिक व्यवस्थाओं तथा दार्शनिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है और विभिन्न संस्कृतियों तथा ऐतिहासिक कालखंडों में इसमें उल्लेखनीय भिन्नता पाई जाती है।

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

ऐतिहासिक दृष्टि से, पाश्चात्य समाजों में बाल्यावस्था को सदैव जीवन के एक विशिष्ट चरण के रूप में नहीं देखा गया। फिलिप एरिस (1962) ने अपनी प्रसिद्ध कृति सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में यह तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यकालीन यूरोप में बच्चों को प्रायः छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता था और उनके विकासात्मक भेदों की विशेष पहचान नहीं की जाती थी। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में प्रबोधन युग (एन्लाइटनमेंट) के विचारों के उदय के साथ बाल्यावस्था को मानव जीवन के एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरण के रूप में समझा जाने लगा, जिसके लिए विशेष देखभाल, संरक्षण और शिक्षा आवश्यक मानी गई।

बाल्यावस्था की आधुनिक अवधारणा के निर्माण में जॉन लॉक और जीन-जैक्स रूसो के दार्शनिक विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जॉन लॉक (1693) ने बालक के मन को टैबुला रासा अर्थात् रिक्त पट्ट के रूप में निरूपित किया, जिसका निर्माण पूर्णतः अनुभव और शिक्षा के माध्यम से होता है। इसके विपरीत, जीन-जैक्स रूसो (1762) ने बच्चों की अंतर्निहित भलाइयों तथा उनके स्वाभाविक विकास पर बल दिया और ऐसी बाल-केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया जो बालक के विकास-स्तर के अनुरूप हो। इन प्रारंभिक विचारों ने आगे चलकर उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की आधारशिला रखी, जिनमें बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक विकास की एक विशिष्ट अवधि के रूप में देखा गया।

बीसवीं शताब्दी में जीन पियाजे और एरिक एरिकसन जैसे विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को एक जैविक रूप से निर्धारित और सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में और अधिक सुदृढ़ किया। पियाजे (1952) ने संज्ञानात्मक विकास का चरण-आधारित मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी बच्चे विकास के निश्चित चरणों से क्रमबद्ध रूप से गुजरते हैं। वहीं, एरिक एरिकसन (1950) ने मनोसामाजिक विकास के चरणों का प्रतिपादन किया, जिसमें बाल्यावस्था के दौरान पहचान के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा बाल-कल्याण नीति जैसे क्षेत्रों में ये दृष्टिकोण प्रभावशाली बने रहे, जिससे यह धारणा सुदृढ़ हुई कि बच्चे अपेक्षाकृत निष्क्रिय प्राणी हैं और परिपक्वता तक पहुँचने के लिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है (एरिका बर्मन, 2008)।

हालाँकि, इस प्रभावशाली विकासात्मक मॉडल की समाजशास्त्रियों और मानवविज्ञानियों द्वारा आलोचना की गई है, क्योंकि यह बच्चों के अनुभवों की विविधता और उनकी सक्रिय भूमिका (एजेंसी) को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखता। एलेन जेम्स और क्रिस प्राउट (1997) जैसे विद्वानों का तर्क है कि बाल्यावस्था केवल एक जैविक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संरचना है, जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों द्वारा आकार ग्रहण करती है।



टिप्पणियाँ

‘बाल्यावस्था का नया समाजशास्त्र’ (NEW SOCIOLOGY OF CHILDHOOD) इस बात पर बल देता है कि बच्चे अपने सामाजिक संसार में सक्रिय सहभागी होते हैं और उन्हें निष्क्रिय आश्रितों के बजाय सामाजिक कर्ताओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अंतर-सांस्कृतिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि बाल्यावस्था की अवधारणा विभिन्न समाजों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। अनेक समाजों में बच्चे कम आयु से ही कार्य करते हैं, पारिवारिक अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और विभिन्न दायित्व निभाते हैं। ये व्यवहार पश्चिमी समाजों में प्रचलित उस आदर्श को चुनौती देते हैं, जिसमें बाल्यावस्था को पूर्णतः संरक्षित और केवल शिक्षा-केंद्रित माना जाता है (बॉयडेन, 1997)। अतः बाल्यावस्था की समकालीन समझ में बहुलताओं को समाहित करना आवश्यक है—इसी दृष्टि को ‘बहुविध बाल्यावस्थाएँ’ (MULTIPLE CHILDHOODS) कहा गया है।



1.1 पाठगत प्रश्न

1. फिलिप एरिस के अनुसार मध्यकालीन यूरोप में बच्चों के बारे में क्या धारणा थी?
 - क. बच्चों को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिन्हें संरक्षण और शिक्षा की आवश्यकता होती है।
 - ख. बच्चों को स्वाभाविक रूप से सद्गुणी प्राणी माना जाता था, जो विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं।
 - ग. बच्चों को छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता था, जिनमें विकासात्मक भेदों की विशेष पहचान नहीं की जाती थी।
 - घ. बच्चों को ऐसे प्राणी माना जाता था जिन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और जो निष्क्रिय होते हैं।
2. जीन-जैक्स रूसो ने बाल्यावस्था को समझने में कौन-सा महत्वपूर्ण योगदान दिया?
 - क. उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जैविक रूप से पूर्वनिर्धारित होती है।
 - ख. उन्होंने बालक को ‘कोरी स्लेट’ (टैबुला रासा) माना।
 - ग. उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की।
 - घ. उन्होंने स्वाभाविक विकास तथा बाल-केंद्रित शिक्षा पर बल दिया।

उत्तर : 1-ग; 2-घ

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

भारतीय पौराणिक परंपरा में बाल्यावस्था से जुड़ी अनेक कथाएँ मिलती हैं, जो भारतीय संस्कृति में गहन अर्थ और महत्व रखती हैं। हिंदू महाकाव्यों और पुराणों में कृष्ण, राम और दुर्गा जैसे पात्रों के बाल-रूपों के माध्यम से पवित्रता, देवत्व, अनुशासन और ब्रह्मांडीय उद्देश्य की विभिन्न अवधारणाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

वृंदावन में कृष्ण का बाल्यकाल चंचलता, सरलता और अद्भुत लीलाओं से परिपूर्ण बताया गया है, जिससे वे बाल्यावस्था के सबसे लोकप्रिय प्रतीकों में से एक बन जाते हैं। माखन-चोरी की उनकी लीलाएँ तथा दानवों का वध इस बात का संकेत हैं कि दैवी सत्ता बालक रूप में संसार में प्रकट होकर आनंद और पवित्रता का समन्वय करती है (पट्टनायक, 2005)। ये कथाएँ दर्शाती हैं कि बाल्यावस्था केवल शारीरिक विकास की अवस्था नहीं है, बल्कि वह ऐसा समय भी हो सकता है जब दैवी चेतना पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है।

इसके विपरीत, राम को रामायण में आदर्श पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। बाल्यावस्था से ही वे आज्ञाकारी, संयमी और उत्तरदायी दिखाई देते हैं। महर्षि वशिष्ठ तथा बाद में विश्वामित्र के सानिध्य में राम का पालन-पोषण धर्म और कर्तव्यबोध पर आधारित है। उनका बाल्यकाल अनुशासन और सदाचार पर बल देता है, जो नैतिक दृष्टि से बालक के निर्माण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है (गोल्डमैन एवं गोल्डमैन, 2004)।

स्त्री का दैवी रूप भी बाल्यावस्था के रूप में प्रकट होता है, विशेषकर देवी दुर्गा के कुमारी स्वरूप में, जिनकी पूजा बंगाल और नेपाल में कुमारी पूजा जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है। यह परंपरा बालिकाओं को पवित्र और अंतर्निहित शक्ति से युक्त मानती है। यह पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देते हुए स्त्रीत्व और बाल्यावस्था को शक्ति और सम्मान से जोड़ती है (किन्सले, 1988)।

ये पौराणिक बाल्यावस्थाएँ केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक प्रथाओं—जैसे नामकरण संस्कार, बाल कथाएँ और पर्व-त्योहार—को भी प्रभावित करती रही हैं। ये बाल्यावस्था को केवल सरलता तक सीमित न रखकर उसे दैवी संभावनाओं, नैतिक दायित्व और आध्यात्मिक चेतना के रूप में प्रस्तुत करती हैं।

आधुनिक भारत में बाल्यावस्था पर सांस्कृतिक परंपराओं के साथ-साथ राज्य की नीतियों और कानूनी परिवर्तनों का भी गहरा प्रभाव है। वर्ष 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। यह पारंपरिक दृष्टि से आगे बढ़कर अधिकार-आधारित बाल्यावस्था की समझ को दर्शाता है (कुमार, 2005)।

यद्यपि नीतिगत सुधार हुए हैं, फिर भी आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ आज भी अनेक बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक समान पहुँच में बाधा

उत्पन्न करती हैं। कई निम्न आय वर्ग के परिवार अब भी घरेलू कार्यों या आय अर्जन के लिए बच्चों पर निर्भर रहते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विवशताएँ कई बार बाल्यावस्था को सीखने और विकास के रूप में देखने की धारणा पर भारी पड़ जाती हैं (प्रथम, 2022)।



1.2 पाठगत प्रश्न

1. कृष्ण, राम और दुर्गा की बाल्यावस्था से जुड़ी कथाएँ किस बात का प्रतिनिधित्व करती हैं?

(संकेत: दैवीय संभावनाएँ, नैतिक दायित्व, अनुशासन, शक्ति एवं आध्यात्मिक चेतना)

2. वर्ष 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) क्या सुनिश्चित करता है?

क. शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता

ख. 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा

ग. 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

घ. रोजगार के लिए समान अवसर

उत्तर : 2 - ग

1.4 समकालीन बाल्यावस्थाएँ

पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तुलना में आधुनिक विश्व में बाल्यावस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। प्रौद्योगिकी, पारिवारिक संरचना, आर्थिक परिस्थितियों तथा शैक्षिक मॉडलों में हुए परिवर्तनों ने बच्चों के विकास, अधिगम और संसार से उनके अंतःक्रिया के तरीकों को बदल दिया है। इन परिवर्तनों ने जहाँ अनेक सकारात्मक अवसर प्रदान किए हैं, वहीं बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास से जुड़ी नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

समकालीन बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता उस पर प्रौद्योगिकी का गहरा प्रभाव है। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप अब विद्यालयी शिक्षा और खेल-कूद सहित दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। बच्चों को प्रायः 'डिजिटल नेटिव' कहा जाता है, क्योंकि वे ऐसे परिवेश में बड़े हो रहे हैं जहाँ प्रौद्योगिकी सर्वत्र



टिप्पणियाँ

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

उपस्थित है (प्रेन्स्की, 2001)। डिजिटल उपकरण अधिगम और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, किंतु अत्यधिक स्क्रीन-समय को शारीरिक गतिविधि में कमी, अपर्याप्त नींद और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं से भी जोड़ा गया है (ट्वेंजी एवं कैपबेल, 2018)।

डिजिटल माध्यमों के व्यापक उपयोग ने साइबर उत्पीड़न तथा मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक मीडिया के प्रभाव को लेकर भी चिंताएँ बढ़ाई हैं। सामाजिक मीडिया बच्चों के सामने अवास्तविक शारीरिक मानक, सहपाठी दबाव और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी स्थितियाँ प्रस्तुत करता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आधुनिक भारत में भी डिजिटल प्रौद्योगिकी और मीडिया ने बाल्यावस्था के अर्थ को बदल दिया है। बच्चे कम आयु में ही बाजार संस्कृति के संपर्क में आ जाते हैं, जिसका प्रभाव उनकी आकांक्षाओं, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है (सिंह, 2011)।

हालाँकि, डिजिटल प्रगति के साथ असमानताएँ भी बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों से आने वाले अनेक बच्चों को प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त नहीं हो पाती। यह डिजिटल असमानता समकालीन भारत में बाल्यावस्था के अनुभवों को और अधिक विषम बनाती है।

डिजिटल प्रभावों के साथ-साथ बदलती पारिवारिक संरचनाएँ भी आज की बाल्यावस्था को परिभाषित करती हैं। तलाक़ में वृद्धि, एकल-अभिभावक परिवारों का बढ़ना तथा दो-आय वाले परिवारों के विस्तार ने पारंपरिक देखभाल की व्यवस्थाओं को रूपांतरित किया है। अनेक बच्चे अब अधिक समय डे-केयर केंद्रों या अन्य देखभालकर्ताओं के साथ बिताते हैं, जिससे उनकी भावनात्मक अनुभूतियाँ और लगाव के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है (बोल्बी, 1988; बेल्स्की, 2001)। साथ ही, परिवार की व्यापक परिभाषाओं और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बढ़ते ध्यान ने कुछ बच्चों के लिए अधिक स्नेहपूर्ण और सहयोगी परिवेश उपलब्ध कराए हैं। यह प्रवृत्ति सकारात्मक पालन-पोषण की ओर संकेत करती है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। बच्चों पर विद्यालयी उपलब्धियों का दबाव पहले की तुलना में अधिक हो गया है और यह दबाव कम आयु से ही आरम्भ हो जाता है। मानकीकृत परीक्षाएँ और प्रतिस्पर्धी विद्यालयी वातावरण तनाव और चिंता को बढ़ा सकते हैं (पोप, 2001)। इसके साथ-साथ, समकालीन शिक्षा में परियोजना-आधारित अधिगम, डिजिटल साक्षरता तथा समावेशी शिक्षा जैसे नवाचारों को अपनाया गया है, ताकि विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और बच्चों को वैश्वीकृत विश्व के लिए तैयार किया जा सके (यूनेस्को, 2021)।

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

आज के बच्चे विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और उनके अनुभव व अवसर भी भिन्न-भिन्न होते हैं। जहाँ कुछ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषणयुक्त आहार और स्वास्थ्य-सेवाएँ उपलब्ध हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर यह सुनिश्चित करने के प्रयास तेज़ हो रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा इन मूलभूत अधिकारों का उपभोग कर सके। यूनिसेफ (2023) के अनुसार, यह स्वीकार करना कि अनेक बच्चे अब भी गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण हेतु सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष तथा कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद (लॉड्स एवं अन्य, 2020), समान अवसरों के सृजन और सभी बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य की दिशा में जागरूकता, सहयोग और नवाचार बढ़ रहे हैं।

आधुनिक भारतीय बाल्यावस्था विकास, अवसर और परिवर्तन का एक गतिशील मिश्रण प्रस्तुत करती है। एक ओर, शहरी क्षेत्रों में अनेक मध्यमवर्गीय परिवार शिक्षा, सृजनात्मकता और भावनात्मक कल्याण को महत्व देने वाले प्रगतिशील, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। दूसरी ओर, बढ़ती जागरूकता और सतत प्रयास ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, जहाँ शिक्षा, सामाजिक संरक्षण और सामुदायिक विकास के नवाचार बच्चों को अपनी क्षमताएँ साकार करने में सहायक हो रहे हैं। समावेशी विकास, कानूनी सुधारों और बदलती मानसिकताओं के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के साथ भारत ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है, जहाँ प्रत्येक बच्चा — पृष्ठभूमि से परे — फल-फूल सके, सीख सके और समाज में सार्थक योगदान दे सके।

यह कहा जा सकता है कि आज की बाल्यावस्था विविधताओं और जटिलताओं से परिपूर्ण है। प्रौद्योगिकीय और सामाजिक प्रगति ने विकास और अधिगम के अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं, किंतु इसके साथ ही नए जोखिमों और असमानताओं को भी जन्म दिया है। आज के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें डिजिटल साक्षरता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शैक्षणिक कठोरता और मानसिक स्वास्थ्य, तथा समानता और अवसर, इन सभी के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। इन जटिल वास्तविकताओं को समझकर और उनके प्रति संवेदनशील होकर हम ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं जो सुदृढ़, संवेदनशील और सक्षम हो।



1.3 पाठगत प्रश्न

1. बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन-समय का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है?

क. समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

ख. शारीरिक गतिविधि में कमी और नींद की समस्या

ग. सामाजिक संबंधों में सुधार

घ. शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि

उत्तर : 1 - ख

1.5 अनेक प्रकार की बाल्यावस्थाएँ

1.5.1 भारत में विभिन्न आर्थिक संदर्भों में बाल्यावस्था

समय, स्थान, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ तथा अनेक अन्य कारक बाल्यावस्था की हमारी अवधारणा और बच्चों के जीवन-अनुभवों को आकार देते हैं (कुमार, 2025)। भारत एक विशाल और अत्यधिक विविधतापूर्ण जनसंख्या वाला देश है, जहाँ रहने और कार्य करने से जुड़ी चुनौतियाँ और अवसर क्षेत्र तथा सामाजिक संदर्भ के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

परिवार की आय के स्तर के अनुसार बच्चों का जीवन अत्यंत भिन्न होता है। ये असमानताएँ न केवल भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक बच्चों की पहुँच को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके विकास, सुरक्षा और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी व्यापक चुनौतियों को भी निर्धारित करती हैं। कुछ बच्चे सुरक्षित वातावरण और पर्याप्त अवसरों के साथ विशेषाधिकार प्राप्त बाल्यावस्था का अनुभव करते हैं, जबकि अनेक अन्य बच्चों को कम आयु से ही अभाव, श्रम और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में बाल्यावस्था को समझना देश की विकास-यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है और यह संकेत करता है कि सभी बच्चों के लिए अधिक समानतापूर्ण और समावेशी भविष्य के निर्माण की दिशा में कहाँ और कैसे प्रयास किए जा सकते हैं।

1.5.2 उच्च आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था

भारत में संपन्न शहरी परिवारों से आने वाले बच्चे प्रायः वैश्विक प्रभावों से युक्त और समृद्ध परिवेश में पलते-बढ़ते हैं। वे साधन-संपन्न विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, संगीत और खेलकूद जैसी विविध सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा कम आयु से ही डिजिटल कौशल विकसित करते हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-सेवाओं और पोषणयुक्त आहार तक पहुँच के कारण ऐसे बच्चों को अपनी रुचियों का अन्वेषण करने और अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अवसर मिलते हैं।

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

इन बच्चों के पास सामान्यतः सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जैसे—अलग कमरा, अध्ययन मेज़, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टैबलेट और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी। उन्हें अपनी पसंद के खिलौनों के साथ खेलने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। अभिभावक उनके भविष्य के लिए वित्तीय संसाधनों और संपत्ति के संचय पर भी ध्यान देते हैं। चूँकि ऐसे परिवारों में प्रायः दोनों अभिभावक नौकरी या व्यवसाय में संलग्न होते हैं, इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए घरेलू सहायक की व्यवस्था होती है। इस संदर्भ में दादा-दादी की भूमिका प्रायः यह सुनिश्चित करने तक सीमित रहती है कि देखभाल उचित ढंग से हो रही है या नहीं।

हालाँकि, इस संरक्षित और सुविधाजनक परिवेश में भी कुछ नई चुनौतियाँ उभर रही हैं, जैसे—अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, खेल और विश्राम के लिए सीमित समय, तथा डिजिटल माध्यमों के प्रति अत्यधिक संपर्क। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के एक अध्ययन में यह पाया गया कि शहरी क्षेत्रों के मध्यम और उच्च आय वर्ग के बच्चों एवं किशोरों में चिंता और उदासी की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका एक प्रमुख कारण शैक्षणिक तनाव और डिजिटल माध्यमों द्वारा बढ़ावा दी जाने वाली सामाजिक तुलना माना गया है। इस प्रकार, यद्यपि संपन्न परिवारों के बच्चों को जीवन-निर्वाह की चिंता नहीं होती, फिर भी वे मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक जोखिमों से पूर्णतः मुक्त नहीं होते।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था अपेक्षाकृत सुरक्षित और सतत निगरानी में व्यतीत होती है। यह अवस्था प्रायः स्नेह, संरक्षण और वयस्कों अथवा देखभालकर्ताओं के मार्गदर्शन में विकास की होती है। उच्च आय वर्ग की बाल्यावस्था को कई दृष्टियों से एक आदर्श रूप माना जा सकता है, क्योंकि इसमें संभावनाएँ, अवसर और सहयोगी समर्थन-तंत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।



1.4 पाठगत प्रश्न

1. शहरी क्षेत्रों में उच्च आय वर्ग के परिवारों की बाल्यावस्था किसका प्रतिनिधित्व करती है?
 - क. शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवाओं तक सीमित पहुँच
 - ख. न्यूनतम निगरानी के साथ स्वतंत्र जीवन
 - ग. शैक्षणिक एवं मनोरंजक सुविधाओं के साथ संरचित और पर्यवेक्षित दिनचर्या

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

घ. प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना केवल पारंपरिक मूल्यों पर आधारित बाल्यावस्था

उत्तर : 1 - ग

1.5.3 मध्यम आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था

भारत के मध्यम आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था एक विशिष्ट अनुभव प्रस्तुत करती है, जिसमें पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और आधुनिकता तथा सामाजिक उन्नति की आकांक्षाओं का संयोजन दिखाई देता है। इन परिवारों में बच्चों के अनुभव विद्यालय तक पहुँच, प्रौद्योगिकी से परिचय, अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएँ तथा बदलते सामाजिक मानदंडों जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। यद्यपि इस वर्ग के बच्चों को निम्न आय वर्ग की तुलना में अधिक सुरक्षा और अवसर प्राप्त होते हैं, फिर भी वे शैक्षणिक दबाव, सामाजिक तुलना और परिवर्तनशील सांस्कृतिक परिवेश जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, जो उनकी प्रारंभिक आयु को विशिष्ट बनाती हैं। संसाधन सीमित होने के कारण बच्चे कम आयु से ही साझा करने और समायोजन करने का महत्व सीखते हैं।

भारत के अधिकांश मध्यम आय वर्गीय परिवारों में शिक्षा को रोजगार प्राप्ति और सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख साधन माना जाता है। बच्चे सामान्यतः प्राइवेट या अर्ध- प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। इस वर्ग के अभिभावक शैक्षणिक उपलब्धि को अत्यधिक महत्व देते हैं और शिक्षकों से नियमित संवाद, गृहकार्य में सहयोग तथा प्राइवेट शिक्षकों की व्यवस्था के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। यह शैक्षणिक उन्मुखता प्रायः स्थिर और सम्मानजनक आजीविका—जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा या सरकारी सेवा—प्राप्त करने की आकांक्षा से प्रेरित होती है।

मध्यम आय वर्ग के परिवार पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। बड़ों के प्रति सम्मान, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता तथा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान पारिवारिक संबंधों और नैतिक आधार को सुदृढ़ करता है। पर्व-त्योहार, पारिवारिक मिलन और धार्मिक गतिविधियाँ बच्चों में अपनत्व और पहचान की भावना विकसित करती हैं। साथ ही, टेलीविज़न, स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से बच्चे वैश्विक संस्कृति से भी परिचित होते हैं, जिससे स्थानीय मूल्यों और वैश्विक लक्ष्यों का समन्वय दिखाई देता है।

अधिकांश मध्यम आय वाले परिवारों के बच्चों को घर पर स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता होती है। इनका उपयोग मनोरंजन के साथ-साथ अधिगम के लिए भी किया जाता है। अनेक बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं, शैक्षिक अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं या

बाल्यावस्था

यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म से गृहकार्य में सहायता लेते हैं। किंतु स्क्रीन के सामने अत्यधिक समय बिताना एक चिंता का विषय भी है, जिससे शारीरिक गतिविधि और सामाजिक सहभागिता में कमी देखी गई है (ट्वेंजी एवं कैंपबेल, 2018)।

अधिकांश समय बच्चों को अवकाश केवल सप्ताहांत में ही मिल पाता है। इस दौरान वे मॉल, सिनेमा हॉल या रिश्तेदारों के घर जाने जैसी गतिविधियों में समय बिताते हैं। संगीत, नृत्य या खेलकूद जैसे शौकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन तो दिया जाता है, किंतु प्रायः इन्हें शैक्षणिक उपलब्धियों की तुलना में कम प्राथमिकता मिलती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं और शहरी क्षेत्रों में सीमित खुले स्थानों के कारण बच्चे प्रायः सुरक्षित परिसरों—जैसे चारदिवारी वाले कॉलोनियों के पार्क या विद्यालय के खेल मैदान—में ही खेल पाते हैं।

मध्यम आय वर्ग के परिवारों के बच्चों की भौतिक परिस्थितियाँ भले ही निम्न आय वर्ग के बच्चों से बेहतर हों, फिर भी उन्हें अपनी विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे प्रमुख है बेहतर प्रदर्शन का दबाव, जो भावनात्मक थकान का कारण बन सकता है। सामाजिक मीडिया इस स्थिति को और जटिल बना देता है, क्योंकि यह बच्चों के सामने आदर्श जीवन-शैलियाँ प्रस्तुत करता है और दूसरों से तुलना के माध्यम से हीन भावना उत्पन्न कर सकता है। तथापि, उचित मार्गदर्शन के साथ सामाजिक मीडिया प्रेरणा, आत्म-अभिव्यक्ति और अधिगम का प्रभावी माध्यम भी बन सकता है, जिससे बच्चे आत्मविश्वास विकसित कर सकें और अपने आसपास की दुनिया से सार्थक रूप से जुड़ सकें।

मध्यम आय वर्ग के बच्चे सामान्यतः नई प्रौद्योगिकियों और वैश्विक अवसरों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल स्थापित कर पाते हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओं और सामाजिक पूँजी तक पहुँच प्राप्त होती है, जो उन्हें बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले संसार में आगे बढ़ने में सहायक होती है। यदि उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन और समर्थन मिले, तो ये बच्चे दृढ़ता, लचीलापन और आत्म-मूल्य की सुदृढ़ भावना विकसित कर सकते हैं।

अतः भारत के मध्यम आय वर्ग में बाल्यावस्था अवसरों, आकांक्षाओं और सीमाओं का एक मिश्रण है। ये बच्चे पारंपरिक अपेक्षाओं और आधुनिक अभिलाषाओं के बीच, अनुशासन और स्वतंत्रता की आवश्यकता के बीच संतुलन साधने का प्रयास करते हैं। यद्यपि उन्हें अच्छे विद्यालय, मजबूत पारिवारिक परिवेश और डिजिटल संसाधन उपलब्ध होते हैं, फिर भी मानसिक दबाव और प्रतिस्पर्धा उनकी बाल्यावस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष बने रहते हैं। इसलिए नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए आवश्यक है कि वे इन अनुभवों की सूक्ष्मताओं को समझें, ताकि केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि संतुलित और सर्वांगीण व्यक्तित्व वाले नागरिकों का



टिप्पणियाँ

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

विकास किया जा सके।

1.5.4 निम्न आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था

निम्न आय वर्ग के परिवारों से आने वाले बच्चों को प्रायः अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, फिर भी शिक्षा तक समान और गुणवत्तापूर्ण पहुँच अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के अनेक सरकारी विद्यालयों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, शिक्षकों की कमी तथा अधिगम संसाधनों का अभाव देखा जाता है (वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2022)। इससे समय के साथ अधिगम-अंतराल भरना कठिन हो जाता है। ASER (2022) के अनुसार, सरकारी विद्यालयों में कक्षा तीन के केवल लगभग 20 प्रतिशत विद्यार्थी ही कक्षा दो के स्तर का पाठ पढ़ पाने में सक्षम थे; यह प्रतिशत पारिवारिक आय के स्तर के अनुसार काफी भिन्न पाया गया।

आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले अनेक बच्चे कम आयु में ही श्रम में संलग्न हो जाते हैं और वयस्कों जैसे दायित्व उठाने को विवश होते हैं। परिणामस्वरूप, वे शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और शिक्षा, खेल तथा समग्र विकास के पर्याप्त अवसरों से वंचित रह जाते हैं। सामान्यतः बाल्यावस्था को मासूमियत, अधिगम और विकास का समय माना जाता है, किंतु भारत में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के कारण बच्चों के अनुभव भिन्न-भिन्न होते हैं। जहाँ कुछ बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाएँ और विकास के अवसर उपलब्ध हैं, वहीं निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिन पर सामूहिक ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता है।

निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चे अक्सर भीड़भाड़ वाले और असुरक्षित आवासीय परिवेश—जैसे झुग्गी-झोपड़ियाँ या न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्र—में बड़े होते हैं। इन परिवारों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत और पोषणयुक्त भोजन जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी हमेशा उपलब्ध नहीं होतीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के 35 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण के कारण अवरुद्ध वृद्धि (STUNTING) से प्रभावित हैं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2021)। कुपोषित बच्चों में बीमारी, थकान और संज्ञानात्मक कमियों की आशंका अधिक होती है, जो विद्यालय में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य-सेवाओं तक पहुँच भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमित संसाधनों और जागरूकता के अभाव में टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य-जाँच जैसी निवारक सेवाओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल पाती। परिणामस्वरूप, निम्न आय



टिप्पणियाँ

वर्ग के परिवारों के बच्चों में बीमारियाँ, संक्रमण और उपचार न हो पाने वाली विकासात्मक समस्याएँ अधिक देखी जाती हैं (यूनिसेफ, 2023)।

आर्थिक बाध्यताएँ अनेक विद्यार्थियों को समय से पहले शिक्षा छोड़ने या पढ़ाई के साथ श्रम करने के लिए विवश करती हैं। बाल श्रम एक निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है, विशेषकर कृषि, घरेलू कार्य, निर्माण तथा लघु उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों में। ऐसे कई बच्चों के लिए आजीविका कमाना शिक्षा और खेलकूद से अधिक प्राथमिक हो जाता है, जिससे सुरक्षित और पोषणकारी बाल्यावस्था के अवसर सीमित हो जाते हैं।

निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को केवल भौतिक अभाव ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। भूख, बीमारी, हिंसा या अभिभावकीय देखभाल के अभाव के कारण दैनिक जीवन की अस्थिरता चिंता, कम आत्मसम्मान और व्यवहार संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। जहाँ अभिभावक कम वेतन वाले कार्यों में लंबे समय तक लगे रहते हैं, वहाँ बच्चों की देखरेख अक्सर बड़े भाई-बहन करते हैं। विशेषकर बालिकाओं पर कम आयु से ही घरेलू कार्यों का बोझ डाल दिया जाता है और वे छोटे भाई-बहनों की देखभाल या शीघ्र विवाह की तैयारी के कारण विद्यालय छोड़ने की अधिक आशंका में रहती हैं (नाम्बिसन, 2010)।

जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर होने वाला सामाजिक बहिष्करण अक्सर आर्थिक गरीबी के साथ मिलकर अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करता है। इस प्रकार का बहिष्करण उनके अवसरों को सीमित करता है और गरीबी तथा असमानता के चक्र को और सुदृढ़ करता है।

संक्षेप में, भारत में निम्न आय वर्ग के परिवारों की बाल्यावस्था अभाव, सहनशीलता और आशा—इन तीनों से चिह्नित होती है। ये बच्चे प्रतिदिन ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और संतोषजनक पालन-पोषण से वंचित कर देती हैं; फिर भी विपरीत परिस्थितियों से उबरने में वे उल्लेखनीय दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं का सुदृढीकरण, लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप, समुदाय की सक्रिय सहभागिता तथा समावेशी विकास रणनीतियाँ शामिल हों। ऐसे प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि प्रत्येक बच्चा — आर्थिक पृष्ठभूमि से परे — समान अधिकारों, अवसरों और गरिमापूर्ण भविष्य की आधारशिला प्राप्त कर सके।

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाली आर्थिक असमानताओं से निपटने के लिए एक व्यापक और अंतर्विभागीय (इंटरसेक्शनल) दृष्टिकोण आवश्यक है। विशेषकर वंचित क्षेत्रों में सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवाओं

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

में अधिक निवेश करना, बुनियादी सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि अत्यधिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को प्रभावी समर्थन मिल सके। साथ ही, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर विशेष ध्यान देना एक अधिक स्वस्थ, शिक्षित और समावेशी पीढ़ी के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1.6 बाल्यावस्था और लैंगिक परिप्रेक्ष्य

सामान्यतः बाल्यावस्था के संदर्भ में जेंडर का आयाम बालकों और बालिकाओं के बीच के अंतर के रूप में चर्चा में आता है। बहुत कम अवसरों पर बाल्यावस्था को लड़का होने या लड़की होने के अनुभव के रूप में समझा जाता है। बार्थोलोमियस और सेनेकेविल्स (2015) ने कार्यशील वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के पारिवारिक जीवन में जेंडर की भूमिका का अध्ययन किया और बाल्यावस्था को जेन्डर के रूप से निर्मित संरचना के रूप में देखा। रेविन कॉनेल (2005) ने बालकों और बालिकाओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं तथा उनके दैनिक व्यवहारों का विश्लेषण किया।

भारत में बाल्यावस्था के अनुभव विविध हैं और वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक कारकों से गहराई से प्रभावित होते हैं। जेंडर इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। जन्म से ही बालकों और बालिकाओं का पालन-पोषण भिन्न तरीकों से किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओं और अवसरों तक उनकी पहुँच में अंतर दिखाई देता है। हाल के दशकों में जेन्डर समानता की दिशा में प्रगति अवश्य हुई है, किंतु विशेषकर निम्न आय वर्ग के परिवारों में बालिकाओं के लिए अनेक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। बाल्यावस्था में जेंडर आधारित अनुभव न केवल बच्चों के वर्तमान स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके भविष्य के दायित्वों, भूमिकाओं और जीवन-पथ को भी आकार देते हैं।

भारत के अनेक क्षेत्रों में बालिकाओं की तुलना में बालकों को प्राथमिकता दिए जाने की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है, जो कई बार जन्म से पहले ही आरंभ हो जाती है। कानूनन प्रतिबंध के बावजूद जेंडर-चयनात्मक गर्भपात की घटनाएँ सामने आती हैं, जिससे लिंगानुपात असंतुलित होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, भारत में जन्म के समय प्रति 1,000 बालकों पर 929 बालिकाएँ हैं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2021)। यह आँकड़ा जन्म-पूर्व स्तर पर भी जारी जेन्डर आधारित भेदभाव की ओर संकेत करता है। पितृसत्तात्मक परंपराएँ — जो बालकों को आर्थिक सुरक्षा, उत्तराधिकार अधिकारों और धार्मिक दायित्वों से जोड़ती हैं, पुत्र-प्राथमिकता का प्रमुख कारण हैं। कई सामाजिक संदर्भों में दहेज जैसी प्रथाओं और आय-अर्जन क्षमता से जुड़ी

पारंपरिक मान्यताओं के कारण बालिकाओं को कम आर्थिक मूल्य का माना जाता है।

भारत में पोषण और स्वास्थ्य-सेवाओं में जेन्डर समानता पर धीरे-धीरे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जो प्रत्येक बच्चे के कल्याण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यद्यपि NFHS-5 (2021) के आँकड़े बताते हैं कि 15-19 वर्ष की आयु की 59.1 प्रतिशत किशोरियाँ एनीमिया से प्रभावित हैं, जबकि यह प्रतिशत किशोर बालकों में 31.1 है, फिर भी इन निष्कर्षों ने नीतिगत ध्यान और सामुदायिक जागरूकता को सुदृढ़ किया है। परिणामस्वरूप, परिवारों के भीतर भोजन और स्वास्थ्य-सेवाओं तक समान पहुँच को बढ़ावा देने वाली पहलों में वृद्धि हो रही है, ताकि बालक और बालिका दोनों को आवश्यक पोषण, स्वास्थ्य-देखभाल और सहयोग मिल सके और वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकें।



टिप्पणियाँ

शिक्षा तक पहुँच में जेन्डर असमानताएँ आज भी विमर्श का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनी हुई हैं। पिछले दो दशकों में भारत ने बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो शिक्षा में जेन्डर समानता के प्रति बढ़ती जागरूकता और नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिर भी, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जहाँ बालिकाओं की विद्यालय छोड़ने की दर अपेक्षाकृत अधिक है। एकीकृत जिला सूचना प्रणाली फॉर एजुकेशन (UDISE) की 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की संभावना बालकों की तुलना में अधिक होती है। इसके प्रमुख कारणों में आर्थिक दबाव, पारिवारिक दायित्व तथा शीघ्र विवाह शामिल हैं। सुरक्षित विद्यालयी वातावरण, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ और सहयोगी सामुदायिक प्रणालियाँ उपलब्ध कराकर किशोरियों को अपनी शिक्षा जारी रखने और अपनी क्षमताओं को साकार करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

दूसरी ओर, बालक सामान्यतः अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने की अधिक संभावना रखते हैं, यद्यपि वे भी कुछ जेन्डर-विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं। अनेक बालकों पर पारंपरिक पुरुषत्व से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने का सामाजिक दबाव रहता है और निम्न आय वर्ग के परिवारों में कुछ बालक परिवार की आर्थिक सहायता हेतु कम आयु में ही विद्यालय छोड़ने को विवश हो जाते हैं। यद्यपि दोनों लिंगों को अलग-अलग बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तथापि शिक्षा और समर्थन तक पहुँच के संदर्भ में बालिकाएँ प्रायः अधिक गहरी और स्थायी संरचनात्मक असमानताओं का अनुभव करती हैं।

जेन्डर संबंधित अपेक्षाएँ न केवल शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती हैं, बल्कि बाल्यावस्था की समग्र दिशा को भी आकार देती हैं। यद्यपि भारत में विवाह की वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है, फिर भी कुछ बालिकाएँ आज भी शीघ्र विवाह के जोखिम का सामना करती हैं। यूनिसेफ (2022) के अनुसार, विश्व

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

में होने वाले बाल-विवाहों में लगभग प्रत्येक चार में से एक भारत में होता है। शीघ्र विवाह प्रायः बालिकाओं की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों तथा सामाजिक अलगाव की स्थिति में डाल सकता है। हालाँकि, बढ़ती जागरूकता, सशक्त कानूनी प्रवर्तन और सामुदायिक पहलों के कारण बाल-विवाह में क्रमिक कमी देखी जा रही है, जिससे अधिक बालिकाएँ अपनी शिक्षा जारी रखने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं। इसके विपरीत, बालकों का समाजीकरण अक्सर भावी आजीविका प्रदाता के रूप में किया जाता है, जिससे वे अपेक्षाकृत कम आयु में ही कार्यबल में प्रवेश कर लेते हैं।

कम आयु से ही बालकों और बालिकाओं का पालन-पोषण भिन्न अपेक्षाओं के साथ किया जाता है। बालिकाओं को प्रायः सौम्य, अनुशासित और परिवार-केंद्रित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि बालकों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें आत्मविश्वासी तथा महत्वाकांक्षी बनने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। ये जेन्डर आधारित अपेक्षाएँ बाल्यावस्था के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती हैं और आगे चलकर उनके जीवन-पथ को भी दिशा देती हैं।

परिवार की संरचना, शैक्षिक प्रथाएँ, मीडिया में प्रस्तुतियाँ तथा धार्मिक शिक्षाएँ—ये सभी मिलकर सामाजिक मान्यताओं को सुदृढ़ करती हैं। परिणामस्वरूप, जेन्डर भूमिकाएँ बच्चों के जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करती हैं, जैसे—खेलने के अवसर, पहनावा, दायित्व तथा भविष्य की आकांक्षाएँ। उदाहरण के लिए, बालिकाओं को प्रायः घरेलू कार्य सौंपे जाते हैं, जबकि बालकों को अपेक्षाकृत अधिक अवकाश और आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है (नाम्बिसन, 2010)।

ये जेन्डर आधारित अपेक्षाएँ बच्चों के सर्वांगीण विकास को सीमित कर सकती हैं, क्योंकि वे उनकी पहचान को स्वतंत्र रूप से खोजने और अभिव्यक्त करने की क्षमता को बाधित करती हैं। बालिकाएँ हीनभावना को आत्मसात कर सकती हैं, जबकि बालकों पर कठोर — और कभी-कभी हानिकारक — पुरुषत्व की धारणाओं के अनुरूप ढलने का दबाव पड़ सकता है।

इन चुनौतियों को पहचानते हुए भारत सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही जेंडर समानता को बढ़ावा देने हेतु अनेक पहलें आरंभ की हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ जेंडर-चयनात्मक प्रथाओं को समाप्त करने और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती हैं, जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएँ वंचित समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयी अवसर उपलब्ध कराती हैं।

वास्तव में समानतापूर्ण बाल्यावस्था सुनिश्चित करने के लिए भारत को जेन्डर

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

असंतुलन के मूल कारणों का निरंतर समाधान करना होगा। इसके अंतर्गत पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों का सृजन करना तथा जागरूकता और समर्थन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों को सशक्त बनाना शामिल है।

निष्कर्षतः, भारत में बाल्यावस्था के अनुभवों को आकार देने में जेंडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि बालक और बालिकाएँ बड़े होने के कई साझा अनुभव रखते हैं, फिर भी गहराई से जड़ें जमाएँ लैंगिक पक्षपात उनके अवसरों, अपेक्षाओं और जीवन-पथ को भिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। जीवन के आरंभिक चरणों से ही लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना न केवल बच्चों के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य है। राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात में निहित है कि प्रत्येक बच्चा, जेंडर की परवाह किए बिना गरिमा, समान अवसर और अपनी पूर्ण क्षमता को साकार करने की स्वतंत्रता के साथ बड़ा हो सके।



1.6 पाठगत प्रश्न

1. भारत में किशोरियों की विद्यालय में कम उपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?

क. आर्थिक दबाव, पारिवारिक दायित्व तथा शीघ्र विवाह

ख. सह-शिक्षा में अध्ययन का दबाव

ग. सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की कमी

घ. डिजिटल संसाधनों की कमी

उत्तर : क

1.7 बाल्यावस्था और डिजिटल संसार

तेज़ी से हो रही तकनीकी प्रगति ने बढ़ते हुए बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटलकरण आज विद्यालय, घर, समाज और बाज़ार—हर जगह दिखाई देता है। मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट उपकरण बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यह परिवर्तन अपने चरम पर पहुँचा और इसके बाद डिजिटल माध्यमों की भूमिका और अधिक स्पष्ट हो गई। विभिन्न डिजिटल सामाजिक मीडिया मंच और अनुप्रयोग, जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि—बच्चों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

उपलब्ध हैं। इनके साथ-साथ ऑनलाइन खेल भी बच्चों के विकास का हिस्सा बन गए हैं, जिन तक वे मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर के माध्यम से पहुँच बना सकते हैं। आज टेलीविज़न भी लगभग हर परिवार का हिस्सा है और बच्चे इससे अलग नहीं हैं। इस प्रकार डिजिटलकरण ने समाजीकरण के लिए एक व्यापक आभासी (वर्चुअल) क्षेत्र निर्मित किया है, जो विशेषकर शहरी संदर्भों में कई बार अभिभावकों, समुदाय और विद्यालय से भी अधिक प्रभाव डालता है। इसलिए कहा जा सकता है कि डिजिटलकरण बच्चों के लिए सामाजिककरण का एक प्रमुख माध्यम बन गया है।

डिजिटलकरण का बाल्यावस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो डिजिटल माध्यम बच्चों को स्वयं और दूसरों के बारे में अपने दृष्टिकोण और समझ को विकसित करने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालय और घर — दोनों स्तरों पर डिजिटल संसाधनों ने अधिगम प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से उपलब्ध व्यापक सूचना ने शिक्षार्थियों को जिन अवधारणाओं का अध्ययन वे कर रहे हैं, उनके प्रति समग्र दृष्टि विकसित करने में सहायता की है। चिल्ड्रेन इन ए डिजिटल वर्ल्ड (यूनिसेफ, 2017) जैसी रिपोर्टों ने यह रेखांकित किया है कि तकनीक बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केवल विकसित देशों में ही नहीं, बल्कि विश्व के निर्धनतम देशों में भी। डिजिटलकरण ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी विशेष सहयोग प्रदान किया है; तकनीक-समर्थित उपकरणों ने उन्हें समाज में अधिक सक्षम और सहभागी बनने में मदद की है।

हालाँकि, बच्चों के जीवन पर डिजिटलकरण के प्रभाव को लेकर अनेक चिंताएँ भी व्यक्त की गई हैं। बाल्यावस्था में डिजिटल उत्पीड़न, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ, रूढ़ छवियाँ तथा अनुपयुक्त सामग्री जैसे जोखिमों की ओर मनोवैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं ने ध्यान आकृष्ट किया है। इसलिए बच्चों के कल्याण के संदर्भ में डिजिटलकरण पर सर्वसम्मति नहीं है।

डिजिटलकरण ने बच्चों की विद्यालयी शिक्षा में भी उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। ई-पुस्तकें, शैक्षिक अनुप्रयोग और ऑनलाइन अधिगम मंच बच्चों को वैयक्तिकृत, अंतःक्रियात्मक और रोचक अध्ययन के अवसर प्रदान करते हैं (लिविंगस्टोन एवं ब्लम-रॉस, 2020)। विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल अधिगम प्रमुख माध्यम बन गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पारंपरिक प्रणालियों के बाधित होने पर तकनीक शैक्षिक अंतराल को कम करने में सहायक हो सकती है (ओईसीडी, 2021)। इसके अतिरिक्त, संवर्धित वास्तविकता (AR) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी तकनीकें जटिल अवधारणाओं को बच्चों के लिए अधिक सुलभ बनाकर अधिगम को प्रभावी बना रही हैं।

डिजिटलकरण औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के अनौपचारिक अधिगम

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

को भी समृद्ध करता है। यूट्यूब, अन्य शैक्षिक मंचों और कोडिंग-आधारित खेलों के माध्यम से बच्चे विद्यालय से बाहर भी नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी रुचियों का अन्वेषण करते हैं। अनुसंधानों के अनुसार, यदि उचित मार्गदर्शन मिले तो बच्चे डिजिटल मीडिया का उपयोग सृजनात्मकता, समस्या-समाधान और आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं (शॉद्रों एवं अन्य, 2018)। डिजिटल कहानी-कथन उपकरण और खेल-आधारित अधिगम परिवेश करते हुए सीखने और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं।

इसके बावजूद, बच्चों द्वारा डिजिटल तकनीक के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी गंभीर चिंताएँ भी हैं। अत्यधिक स्क्रीन-समय सबसे अधिक चर्चा का विषय है। अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने वाले बच्चों में ध्यान की समस्या, नींद में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं (ट्वेंजी एवं कैम्बेल, 2018)। अमेरिकन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (2016) के अनुसार, अत्यधिक मीडिया उपयोग विशेषकर छोटे बच्चों में मोटापा, नींद की समस्याएँ और व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल खेल और सामाजिक मीडिया अत्यधिक आकर्षक और यहाँ तक कि लत लगाने वाले हो सकते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधियों में कमी और प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क घट सकता है।

बाल्यावस्था में डिजिटलकरण से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा गोपनीयता और डेटा संरक्षण है। अनेक डिजिटल मंच बच्चों और किशोरों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं, प्रायः बिना उनकी स्पष्ट सहमति के या बिना अभिभावकों की प्रभावी निगरानी की व्यवस्था के। इस प्रकार का अनावृत संपर्क बच्चों को लक्षित विज्ञापनों, निगरानी तथा यहाँ तक कि ऑनलाइन शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है (लिविंगस्टोन, 2019)।

डिजिटल सूचना का बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास पर प्रभाव भी एक जटिल विषय है। सामाजिक मीडिया मंच बच्चों को संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर सकते हैं, किंतु साथ ही वे साइबर उत्पीड़न, अप्राप्य सौंदर्य मानकों और सामाजिक तुलना के जोखिम भी उत्पन्न करते हैं (नेसी एवं अन्य, 2018)। छोटे बच्चों के लिए बिना छँटी हुई सामग्री तक पहुँच हानिकारक हो सकती है; इसलिए अभिभावकों द्वारा मीडिया साक्षरता में मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि वे ऑनलाइन देखी जाने वाली सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ताकि इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग कर सकें।

इन चुनौतियों के बावजूद, डिजिटलकरण सुलभता और समावेशन को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए डिजिटल उपकरण अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये संप्रेषण और सहभागिता के वैकल्पिक साधन

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

उपलब्ध कराते हैं (यूनिसेफ, 2017)। स्पीच-टू-टेक्स्ट अनुप्रयोग और स्क्रीन रीडर जैसी सहायक प्रौद्योगिकियाँ अधिगम और सहभागिता को उन तरीकों से संभव बनाती हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं थे।

संक्षेप में, डिजिटलकरण आधुनिक बाल्यावस्था का एक अनिवार्य पक्ष है। यह अधिगम, सृजनात्मकता और संपर्क के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, परंतु इसके साथ स्वास्थ्य, गोपनीयता और विकास से जुड़े जोखिम भी उपस्थित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटलकरण बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले, संतुलित और सूचित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें मीडिया साक्षरता, अभिभावकीय सहभागिता और नैतिक डिज़ाइन पर विशेष ध्यान दिया जाए। नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और परिवारों को मिलकर ऐसे डिजिटल परिवेश का निर्माण करना होगा जो सुरक्षित, समावेशी और बच्चों के विकास के अनुकूल हों।



1.7 पाठगत प्रश्न

1. अध्याय में की गई चर्चा के अनुसार, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी (डिजिटलकरण) का बच्चों पर कौन-सा सकारात्मक प्रभाव है?

क. औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता को चुनौती देना

ख. डिजिटल संसाधनों तक पहुँच से अधिगम और सृजनात्मकता में वृद्धि

ग. प्रत्यक्ष सामाजिक गतिविधियों और आमने-सामने की सहभागिता में वृद्धि

घ. सहपाठी समूह के साथ अंतःक्रिया में कमी

2. बच्चों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से जुड़ी एक प्रमुख चिंता क्या है?

क. अभिभावकों के साथ बेहतर संवाद

ख. सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि

ग. समुदाय के साथ सामाजिक सहभागिता में वृद्धि

घ. साइबर उत्पीड़न और गोपनीयता के ह्रास से संबंधित चिंता

उत्तर : 1 – ख; 2 – घ



1.8 सारांश

1. बाल्यावस्था की अवधारणा स्थिर या सार्वभौमिक नहीं है; यह एक सामाजिक और ऐतिहासिक संकल्पना है, जो समय के साथ विकसित होती रही है।
2. अतीत में पाश्चात्य समाजों में बाल्यावस्था को सदैव जीवन के एक पृथक चरण के रूप में नहीं देखा जाता था।
3. सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में प्रबोधन विचारों के उदय के साथ बाल्यावस्था को जीवन के एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरण के रूप में समझा जाने लगा, जिसके लिए विशेष देखभाल, संरक्षण और शिक्षा आवश्यक मानी गई।
4. समाजशास्त्रियों और मानवविज्ञानियों ने प्रचलित विकासात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की है, क्योंकि यह बच्चों के अनुभवों की विविधता और उनकी सक्रिय भूमिका की उपेक्षा करता है।
5. भारतीय पौराणिक परंपरा में कृष्ण, राम और दुर्गा की बाल्यावस्था से जुड़ी अनेक कथाएँ मिलती हैं, जो बाल्यावस्था को दैवी संभावनाओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ती हैं।
6. प्रौद्योगिकी, पारिवारिक संरचनाएँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और शैक्षिक व्यवस्थाएँ बच्चों के विकास, अधिगम और संसार से उनके संबंधों को गहराई से प्रभावित कर रही हैं।
7. स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर आज बच्चों के दैनिक जीवन, विद्यालय और खेल — का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं; इसी कारण बच्चों को प्रायः 'डिजिटल मूल निवासी' कहा जाता है।
8. बदलती पारिवारिक संरचनाएँ, जैसे तलाक़, एकल-अभिभावक परिवार और दो-आय वाले परिवार, बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण के तरीकों को बदल रही हैं।
9. आज बच्चों पर शैक्षणिक उपलब्धियों का दबाव पहले की तुलना में अधिक है, जो कम आयु से ही तनाव और चिंता को जन्म दे सकता है।
10. भारत में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक विविधता के कारण बाल्यावस्था के अनुभव भी अत्यंत विविध हैं।
11. उच्च आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था अपेक्षाकृत सुरक्षित, संरक्षित और वयस्कों की निगरानी में व्यतीत होती है, जहाँ विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।



टिप्पणियाँ

बाल्यावस्था



टिप्पणियाँ

12. मध्यम आय वर्ग के परिवारों में बाल्यावस्था अवसरों, आकांक्षाओं और सीमाओं का मिश्रण होती है, जहाँ बच्चे अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं।
13. निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे दृढ़ता और आशा के साथ चुनौतियों से जूझते हैं।
14. भारत में बाल्यावस्था को आकार देने में जेंडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है; गहराई से जड़ें जमाए जेन्डर पूर्वाग्रह बालकों और बालिकाओं के अवसरों और अपेक्षाओं को भिन्न रूप से प्रभावित करते हैं।
15. डिजिटलकरण आधुनिक बाल्यावस्था का एक अनिवार्य पक्ष बन चुका है। यह अधिगम, सृजनात्मकता और संपर्क के नए अवसर प्रदान करता है, परंतु इसके साथ स्वास्थ्य, गोपनीयता और विकास से जुड़े जोखिम भी जुड़े हुए हैं।



1.9 पाठांत प्रश्न

1. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से यह स्पष्ट कीजिए कि बाल्यावस्था कोई एकरूप अनुभव नहीं है; बल्कि भारत में अनेक प्रकार की बाल्यावस्थाएँ पाई जाती हैं।
2. समकालीन विश्व में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। भारत में बाल्यावस्था के अनुभवों को प्रौद्योगिकी किस प्रकार आकार देती है?
3. उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि बाल्यावस्था के विकास-क्रम को निर्धारित करने में जेंडर एक महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है?
4. समय के साथ बाल्यावस्था की अवधारणा में किस प्रकार परिवर्तन आया है? विवेचना कीजिए।
5. लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने आज बाल्यावस्था को समझने की हमारी दृष्टि को किस प्रकार प्रभावित किया?
6. आधुनिक समय में बाल्यावस्था को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?
7. शहरी क्षेत्रों में उच्च आय वर्ग के परिवारों के बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

8. भारत में बाल्यावस्था के दौरान जेंडर की क्या भूमिका होती है? स्पष्ट कीजिए।

बाल्यावस्था

1.10 संदर्भ ग्रंथ

American Academy of Pediatrics. (2016). Media and young minds. *Pediatrics*, 138(5), e20162591. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2591>

Annual Status of Education Report (ASER). (2022). ASER 2022 – Rural. ASER Centre. <https://www.asercentre.org>

Ariès, P. (1962). *Centuries of childhood: A social history of family life*. Vintage Books.

Belsky, J. (2001). Emanuel Miller Lecture: Developmental risks (still) associated with early child care. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42(7), 845–859. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00782>

Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic Books.

Boyden, J. (1997). Childhood and the policy makers: A comparative perspective on the globalization of childhood. In A. James & A. Prout (Eds.), *Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood* (pp. 190–229). Falmer Press.

Burman, E. (2008). *Deconstructing developmental psychology* (2nd ed.). Routledge.

Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0–8) and digital technology: A qualitative exploratory study across five European countries. European Commission Joint Research Centre.

Erikson, E. H. (1950). *Childhood and society*. W. W. Norton & Company.

Goldman, R. P., & Goldman, S. J. (2004). *The Ramayana of Valmiki: An epic of ancient India* (Vols. 1–3). Princeton University Press.

James, A., & Prout, A. (1997). *Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood* (2nd ed.). Falmer Press.

Kinsley, D. (1988). *Hindu goddesses: Visions of the divine feminine in the Hindu religious tradition*. University of California Press.



टिप्पणियाँ



टिप्पणियाँ

- Kumar, K. (2005). Political agenda of education: A study of colonialist and nationalist ideas. Sage Publications.
- Kumar, K. (2016). Politics of education in colonial India. Routledge India.
- Kumar, S. (2025). Interdisciplinary approaches to childhood. In N. Ranganathan (Ed.), Contemporary perspectives on childhood and adolescence. Routledge.
- Livingstone, S. (2019). Children: A special case for privacy? *Intermedia*, 47(2–3), 18–23.
- Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). Parenting for a digital future: How hopes and fears about technology shape children's lives. Oxford University Press.
- Loades, M. E., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., ... & Crawley, E. (2020). Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 59(11), 1218–1239.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009>
- Locke, J. (1693). Some thoughts concerning education. A. and J. Churchill.
- Ministry of Health and Family Welfare. (2021). National Family Health Survey-5 (2019–21). Government of India. <https://rchiips.org/nfhs/>
- Nambissan, G. B. (2010). Exclusion and discrimination in schools: Experiences of Dalit children. Indian Institute of Dalit Studies Working Paper Series, 1(1).
- Nesi, J., Choukas-Bradley, S., & Prinstein, M. J. (2018). Transformation of adolescent peer relations in the social media context: Part 1—A theoretical framework and application to dyadic peer relationships. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 21(3), 267–294. <https://doi.org/10.1007/s10567-018-0261-x>
- National Institute of Mental Health and Neurosciences. (2019). National mental health survey of India 2015–16.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). The state of school education: One year into the COVID pandemic. OECD Publishing.



टिप्पणियाँ

- <https://www.oecd.org/education/state-of-school-education-one-year-into-COVID.htm>
- Pattanaik, D. (2005). The book of Krishna. Penguin Books India.
- Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children (M. Cook, Trans.). International Universities Press.
- Pope, D. (2001). Doing school: How we are creating a generation of stressed-out, materialistic, and miseducated students. Yale University Press.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Rousseau, J. J. (1762). Émile, or On education. Basic Books.
- Singh, M. (2011). Childhood and the cultural construction of gender: Reflections from India. International Journal of Sociology of the Family, 37(1), 27–50.
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. Preventive Medicine Reports, 12, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>
- Unified District Information System for Education Plus. (2022). UDISE+ 2021–22. Ministry of Education, Government of India. <https://udiseplus.gov.in>
- UNESCO. (2021). Education and the COVID-19 pandemic. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNICEF. (2017). Children in a digital world: The state of the world's children 2017. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2017>
- UNICEF. (2020). COVID-19 and children in India. <https://www.unicef.org/india/reports/covid-19-and-children-india>
- UNICEF. (2022). Ending child marriage: A profile of progress in India. <https://www.unicef.org/india/reports/ending-child-marriage>
- UNICEF. (2023). Child poverty – Global study. <https://www.unicef.org/reports/global-child-poverty-report-2023>
- UNICEF. (2023). State of the world's children 2023: For every child, health. <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2023>